Identifikace pacienta
Jméno pacienta: **Lenka**
Příjmení pacienta: **Kabátová**
Rodné číslo:
Pojišťovna pacienta: **205**

Zdravotní stav a diagnózy
Anamnéza: **Pacientka premorbidně soběstačná, s anakuzí dlouhodobě vpravo, hypakuzí vlevo. Přivezena pro náhle vznikle vertigo se zvracením a se zhoršením sluchu na leve ucho. Při příjmu celkem harmonický vestibulární syndrom se zánikem vpravo, těžká hypakuze až anakuze. NA KK bez lateralizace.CTm: AS encephalopatie, CTA bez LVO. V dif. diagnóze suspektní ischemie ve vertebrobazilárním povodí, proto příjem na neurologickou JIP – NIHSS však 0 bodů, IVT neindikována, do medikace ASA. Do ordinace přidány kortikoidy. Doplněno ORL vyšetření: vertigo, t.č. bez jasného PVS, v.s. stp. CMP. Doporučeno pokračovat v kortikoidech a Betasercu. Během hospitalizace bez zlepšení stavu stran anakuze, ale chůze bez titubace, spíše lakunární. Doplněno MRm: v. s. neurinom akustiku vlevo, , drobná postischemická léze v mozečku vlevo staršího data Fazekas III. Atrofie. Pac. popuštěna do domácí péče. Dál doplneno MRm s KL, kde už po pis TU charakteru Schwanomu n. VIII sin. Drobný meningeom F parafalcinně sin, vel. do 6mm, bez imprese přilehlých gyrů.**

Zobrazovací vyšetření: **MR - MR mozku založeno: 04.09.2026 10:59 - poslední změna: 04.09.2026 12:45 - MR mozku, nativní vyšetření: Provedeny sekvence: T2W TSE axiálně, 3D FLAIR FS sagitálně + rekonstrukce, 3D T1W sagitálně, SWI Ven bold i MinIP SWI axiálně. DWI i dADC b0-500-1000 axiálně, VISTA transversálně na zadní jámu lební. Infratentoriálně ve ventrokraniálním okraji levé mozečkové hemisféry je drobná, ostře ohraničené oblast 15x14x8mm, T1 hypo a T2 hypersignální, bez edému, bez restrikce difuze. Drobný proužek gliozy v levém pedukulu. V levém vnitřním zvukovodu, který není rozšířený, je v průběhu nervů hyposign. ložikso cca 7x3x4mm. Nepřesahuje okraj vnitřního zvukovodu. Supratentoriálně jsou peri i paraventrikulárně a frontálně až juxtakortikálně vícečetná splývající T2/FLAIR hypersignální ložiska bílé hmotě až větší okrsky gliozy. Hippokampy mají symetrickou velikost, vlevo drobné perivaskulární lakuny, oboustranně s rozšířením liqur. prostor v jejich okolí. Středočárové struktury bez patologie. Tentorium a falx přiměřené šíře. Komorový systém a SA systém širší- 3. komora 14mm. Optické nervy, chiasma a optické trakty normální šíře, beze změny signálu.Struktury orbit symetrické, beze změny signálu. Hypofýza intraselárně zanořena, přiměřené**

velikosti i signálu. Sklípkové systémy pyramid a mastoidálních sklípků bez známek patologie, stranová asymetrie v pneumatizaci hrotu pyramin- větší pneumatizace vpravo. PND bez známek patologie. Vyšší sliznice na nosních konchách. Kalva a baze lební normálního signálu. Závěr: Drobné ložisko v levém vnitřním zvukovodu intrameatálně bez jeho dilatace- v.s. neurinom akustiku vlevo- Koos I. (vhodné upřesnit podáním k.l.). Drobná postischem. léze v mozečku vlevo staršího data. Nespecifická splývající ložiska v bílé hmotě peri a paraventrikulárně, frontálně jsou i juxtakortikálně- Fazekas III. Atrofie. MR - MR mozku založeno: Dplnění MR mozku, nativní + postkontrast. vyš.: T1W iso 3D Brain VieW sagitálně VISTA MPR na zadní jámu Postkontrastně T1 3D MPR a black blood 3D. Homogenní solid. sycení intrameatal. TU popis. na minulém nativním MR vyš., vel. do 7mm. Bez propagace do cisternal. porce či do oblasti labyrintu - charakteru Schwanomu n. VIII sin.. Blíže viz min. MR. Drobný meningeom F parafalcinně sin, vel. do 6mm, bez imprese přilehlých gyrů. Jinak postkontrsatně bez jiných ložiskkových či jiných patol. změn. Přístroje: Magnetická rezonance, Magnetická rezonance (MRI, NMR) , 84669

Aktuální klinicky stav: **Většinou sobestačna, spolu s přybuznymí bydlicí . Chodicí. Osobní anamnezá: HN II. komp., HLP, DM II. na PAD, polynodosní struma ve sledování, bez medikace, potíže s ní nemá. St.p.op. extrauterinní gravidity, přitom provedena APE, st.p. sutuře Achillovy šlachy vpravo, v dětství st.p. op. zlomeniny femoru vpravo., st.p. TEP coxae l.dx. -9/2016**